

Intestino Primitivo anterior:

Superior	Mesogastrio Ventral: Desde esófago caudal.	Mesogastrio Dorsal: Todo intestino primitivo.
Día 24: Disgregación membrana bucofaríngea.		
Divertículo Respiratorio. <i>Evaginación</i> ventral: faringe primitiva Día 26. NKX2.1: E. Columnar respiratorio.	Hígado	Bazo
Esófago. Se encuentra por dorsal. SOX 2: E. plano de revestimiento. Semana 4: Divertículo. Semana 5: Tabique. Semana 6: División completa.	Vesícula Biliar Se forma por evaginación del conducto biliar.	Bolsa Omental
Estómago. Mayor índice mitótico por posterior.	Yema pancreática ventral + Conducto Principal.	Yema Pancreática Dorsal + Conducto Accesorio
Duodeno: Hasta ampolla hepatopancreática.	Ligamento Falciforme	Ligamento Gastroesplénico.
	Ligamento Hepatoduodenal.	Ligamento Esplenorrenal.
	Septum Transverso	Ligamento Pancreático esplénico.
	Omento menor	Omento mayor

Permeabilidad esofágica total: Es en la semana 8.

Mesénquima esplácnico entrega musculatura esofágica.

Muller: Invaginación del epitelio celómico dorsal.

Tubérculo Sinusal: Pared dorsal del seno urogenital en hombres y mujeres.

Semana	Estructura
4	Esófago formado Primordio hepático (<i>evaginación</i>) en el septum transverso. Cordón Nefrogénico.
5-6	Aumento índice mitótico en la cara posterior del estómago.
5	Diferenciación estructuras por evaginaciones. Sinusoides hepáticos.
6	Rotaciones estómago. Longitudinal en su 1/3 caudal.
7	Unión yemas pancreáticas. Ventral: Cabeza y Uncus. Dorsal: Cuerpo y Cola.
8	Fusión yemas pancreáticas.
8	Posiciones definitivas.
8	Musculatura circular esófago.
13	Musculatura longitudinal.
25	Epitelio escamoso.

Rotación + sentido	Consecuencia
Rotación ventro-dorsal	Horizontalidad: diferenciación izquierda bazo y derecha hígado.
Rotación longitudinal 90° a la derecha	Provoca que lo derecho quede posterior y lo izquierdo anterior. Relación con N. X.

Rotación longitudinal hace que el hígado quede en su posición final.

Estenosis duodenal: Entre D2 y D3.

Wolff: Se forma del pronefro.

El omento mayor se fusiona con el mesocolon transverso.

Los plegamientos embriológicos inician en la semana 4 para formar el intestino primitivo, el plegamiento transversal es fundamental en este proceso.

Ácido Retinoico: Diferenciación de las 3 porciones del intestino. De menos a más en posterior.

Intestino Primitivo Medio.

Se extiende desde D1 hasta los 2/3 derechos del colon transverso.

Asa craneal	Asa caudal
Asa duodeno yeyunal.	Ciego.
Asa yeyuno ileal.	Colon ascendente.
Intestino delgado.	Colon transverso derecho.

Semana	Rotación izquierda	Resultado
6	0	Asa craneal y caudal.
8	90° derecha	Asa craneal ahora derecha y la caudal queda a la izquierda. Aquí formación asas yeyunoileales.
10	+ 90° = 180°	Asa craneal derecha ahora hacia inferior y la caudal hacia superior.
11	+ 90° = 270°	Asa craneal de inferior queda a la izquierda y la caudal queda a la derecha.

Semana	Ocurre
5	Cordón umbilical.
5-6	Obliteración del lumen intestinal.
6	Aparición hernia fisiológica.
7-8	Vacuolización del lumen intestinal.
12	Descenso ciego y ecografía para descartar onfalocele .

Estenosis intestinal: Lumen estrecho. Más común en D3 – D4.

Atresia: No hay lumen. Más común en D2 – D3.

Divertículo de Meckel: a 20cm de la unión ileocecal. Puede provocar diverticulitis que se puede diferenciar por dolor en la zona baja.

Intestino posterior

Estructura.	Semana	Descripción
Cloaca.	4-5	Cavidad terminal común del intestino posterior y sistema urogenital, es donde llega alantoides.
Tabiques cloacales.	4-7	Rathke y Tourneux formando el tabique urorrectal por fusión de ambos tabiques.
Seno urogenital.	6	Porción ventral derivada de la segmentación de la cloaca.
Conducto anorrectal.	6	Porción dorsal derivada de la cloaca que originará recto y parte del canal anal.
Membrana Cloacal.	6	Cierra la cloaca. Membrana formada por ectodermo y endodermo sin mesodermo interpuesto.
Segmentación cloacal. Tabique Urorrectal.	7	El tabique urorrectal divide la cloaca en seno urogenital y conducto rectoanal. Ano Imperforado.
Membrana urogenital.	7-8	Membrana anterior derivada tras la división de la membrana cloacal.
Fragmentación de la membrana anal.	8	Permite la apertura del ano al exterior. Ano Imperforado.

Porción del canal anal	Origen embrionario	Tipo de epitelio
2/3 superiores.	Endodermo.	Epitelio cilíndrico.
1/3 inferior.	Ectodermo derivado del proctodeo.	Epitelio plano estratificado queratinizado o no.

Los supositorios funcionan rápidamente por el retorno venoso diferente saltándose el paso por el hígado y pasa directamente a metabolizarse.

Fallas de tabique.

Masculino	Femenino
Recto vesical.	Recto vaginal superior / Douglas.
Recto prostático.	Recto vaginal inferior.
Recto membranoso.	Recto vestibular.
Recto perineal.	Recto bulbar.

Los fallos en el tabique suceden por la no formación de estos, es decir, no se genera la cuña mesenquiática que separa la cloaca.

Mesos y omentos:

Nombre	Lugar	Relación
Toldt 1.	Retrocolica derecho.	+ 4: +3.
Toldt 2.	Retrocólica izquierda.	Aislada.
Fredet.	Predoduodenopancreática. Se encuentra ventral a la bolsa omental.	+1 Retroperitoneo.
Treitz.	Retroduodenopancreática. Se encuentra dorsal a la bolsa omental.	+1 Aorta.

La Arteria Esplénica se encuentra por lateral a la bolsa omental o cavidad retrogástrica y forma un arco con concavidad hacia medial.

La Arteria Gástrica izquierda: se ubica sobre la cavidad omental y forma un arco con concavidad inferior.

Estas fascias de coalescencia permiten la intervención del sector retroperitoneal sin invadir peritoneo.